



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 03 — Acidente Vascular Cerebral: isquêmico, hemorragia intracerebral e hemorragia subaracnóidea (+ AIT)

Reconhecimento, estabilização, controle pressórico, critérios de trombólise/trombectomia e regulação para Centro de AVC — cenário: pronto-socorro sem neurologia, sem UTI e [tomografia: VERIFICAR disponibilidade local]

Código	PS-ND-03	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

"Tempo é cérebro": a cada minuto de oclusão de grande artéria perdem-se ~1,9 milhão de neurônios. A função do PS Natal Diegues é **reconhecer em minutos, estabilizar, não errar (glicemia, PA, decúbito, jejum) e transferir para um Centro de AVC dentro da janela**. Se o serviço tiver tomografia 24 h e acesso a neurologista por tele-AVC, pode-se operar o modelo *drip-and-ship* (trombolisar aqui e transferir) — seção 6.3; caso contrário, o fluxo é de *transferência imediata* sem tomografia prévia.

Fontes de ancoragem: Ministério da Saúde. *PCDT do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo* — Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 29, de 12/12/2023 [PCDT-MS 2023]; Portaria GM/MS nº 1.996/2023 (trombectomia no SUS); Linha de Cuidado do AVC na Rede de Urgência (Portaria de Consolidação nº 3/2017, arts. 128-137); **AHA/ASA 2026 Guideline for the Early Management of Acute Ischemic Stroke** [AHA 2026]; AHA/ASA 2022 Guideline for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage [AHA-HIC 2022]; AHA/ASA 2023 Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Guideline [AHA-HSA 2023]; Diretrizes SBDCV/ABN (Arq Neuropsiquiatr 2012 partes I e II; 2017 tratamento endovascular; HIC 2009); Anvisa — aprovação da tenecteplase 25 mg para AVCi (dez/2025; mercado abr/2026).

Convenção de confiança: doses e critérios trazem a fonte; itens marcados **[VERIFICAR]** exigem conferência local (disponibilidade de TC, tele-AVC, trombolítico, agentes de reversão, hospital de referência). Nada substitui o julgamento clínico.

1. Queixa — como o paciente chega

Déficit neurológico **focal, de instalação súbita**: "a boca entortou", "o braço/perna ficou mole de um lado", "parou de falar / fala enrolada", "não entende o que falamos", "caiu e não levanta", "perdeu a visão de um lado", "tontura com desequilíbrio e vista dupla". Frequentemente quem descreve é o acompanhante — **a pergunta mais importante é: a que horas ele foi visto normal pela última vez?** (LSN — last seen normal). AVC ao despertar: LSN = hora em que dormiu.

Apresentação	Suspeitar de
Cefaleia súbita "a pior da vida" (thunderclap), com/sem rigidez de nuca, síncope, vômitos	Hemorragia subaracnóidea — mesmo sem déficit focal
Déficit focal + cefaleia intensa + vômitos + rebaixamento progressivo + PA muito alta	Hemorragia intracerebral

Apresentação	Suspeitar de
Déficit focal que resolveu completamente em minutos/horas	AIT — mesmo risco de AVC nas próximas 48 h: não dar alta sem estratificar
Vertigem + ataxia + diplopia + disfagia/disartria + déficit cruzado	AVC de circulação posterior (pior prognóstico; oclusão de basilar)
Coma súbito, tetraparesia, pupilas anormais	Oclusão de basilar ou HIC de tronco/cerebelo
Déficit focal em jovem, com dor cervical, trauma/manipulação recente	Dissecção arterial cervical

2. Clínica — triagem, escalas e diferenciais

2.1 Triagem em 60 segundos — Cincinnati / FAST / BE-FAST [PCDT-MS 2023, 3.1]

Sinal	Como testar	Positivo se
Face (queda facial)	"Mostre os dentes / sorria"	Assimetria
Arms (braços)	Braços estendidos a 90° por 10 s, olhos fechados	Um braço cai ou não se mantém
Speech (fala)	"Na casa do padeiro nem sempre tem trigo"	Palavras incompreensíveis, trocadas ou ausência de fala
Balance / Eyes	Desequilíbrio súbito; perda visual mono/bilateral ou diplopia	Presente — captura circulação posterior
Time	Hora do LSN; acionar fluxo de AVC	Qualquer item positivo = AVC até prova em contrário

2.2 NIHSS — aplicar na chegada e a cada reavaliação (0-42)

Item	Pontuação	Item	Pontuação
1a. Nível de consciência	0-3	1b. Perguntas (mês, idade)	0-2
1c. Comandos (abrir/fechar olhos, apertar mão)	0-2	2. Olhar conjugado	0-2
3. Campos visuais	0-3	4. Paralisia facial	0-3
5. Motor MSE / MSD (10 s)	0-4 cada	6. Motor MIE / MID (5 s)	0-4 cada
7. Ataxia de membros	0-2	8. Sensibilidade	0-2
9. Linguagem	0-3	10. Disartria	0-2
11. Extinção / negligência	0-2	Interpretação	0-4 leve • 5-15 moderado • 16-20 mod./grave • ≥21 grave

NIHSS ≥6 com déficit cortical (afasia, negligência, desvio do olhar) sugere oclusão de grande vaso — candidato a trombectomia. Déficit **leve e não incapacitante** (NIHSS 0-5 sem afasia/hemianopsia/perda de função relevante) não se beneficia de trombólise (AHA 2026); déficit leve **incapacitante** (ex.: afasia isolada) beneficia-se.

2.3 Escala de Rankin modificada pré-AVC (mRS) — define elegibilidade a trombectomia (≤2)

0 sem sintomas • 1 sintomas sem incapacidade • 2 incapacidade leve, independente • 3 precisa de alguma ajuda, anda sem auxílio • 4 não anda sem ajuda, dependente para AVDs • 5 acamado, incontinente • 6 óbito.

2.4 Mimetizadores e diferenciais [PCDT-MS 2023, 3.4]

Condição	Pistas
Hipoglicemia	Glicemia capilar <50–60 mg/dL; déficit que reverte com glicose — medir em todo paciente antes de qualquer decisão
Crise epiléptica / paralisia de Todd	Sintomas positivos (abalos), incontinência, mordedura, história de epilepsia; déficit pós-ictal regride em horas (10% dos AVC embólicos convulsionam — não exclui)
Enxaqueca com aura	Sintomas visuais positivos (cintilações) que progridem em minutos, cefaleia subsequente, história prévia
Hematoma subdural, tumor, abscesso	Curso subagudo (dias/semanas), trauma, febre, cefaleia progressiva
Vestibulopatia periférica	Vertigem sem outros sinais de tronco; HINTS (impulso cefálico +, nistagmo unidirecional, sem skew) sugere periférico — na dúvida, tratar como central
Encefalopatia tóxico-metabólica, sepse, hipo/hipernatremia	Déficit difuso, flutuante, sem lateralização clara
Conversivo/funcional	Inconsistências ao exame (Hoover, dar diagnóstico de exclusão só após imagem)

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / conduta
Via aérea, respiração	Glasgow ≤ 8 , vômitos com rebaixamento, hipóxia: proteger via aérea; SpO ₂ alvo >94%; não dar O₂ a normoxêmico (AHA)
PA nos dois braços; FC; ritmo	PA alta é a regra e é protetora no AVCi (não baixar de rotina); assimetria >20 mmHg → dissecação de aorta; FA no monitor
Glicemia capilar	Corrigir <60 mg/dL imediatamente; tratar >180
Exame neurológico dirigido (NIHSS)	Lateralidade, afasia vs disartria, campo visual, olhar conjugado (desvia para a lesão no AVCi hemisférico), negligência
Sinais de HIC/HSA	Cefaleia intensa, vômitos, rigidez de nuca, rebaixamento progressivo, anisocoria, PA >220/120
Pele e sítios de sangramento	Petéquias, punções recentes, cirurgia — contraindicações à trombólise
Cardiovascular	Sopros carotídeos, arritmia (FA), sopro valvar (endocardite?), sinais de IC
Temperatura	Febre $\geq 37,5$ °C piora desfecho — antitérmico e buscar foco

4. Propedêutica armada

Exame	O que esperar / para que serve	Prazo
Glicemia capilar	Único exame obrigatório antes de decidir trombólise (além da TC)	Na triagem
TC de crânio sem contraste	Exclui hemorragia (hiperdensidade); AVCi pode ser normal nas primeiras horas (sinais precoces em até 67% em 3 h: apagamento de sulcos, perda da diferenciação córtex-substância branca, hiperdensidade da ACM). Hipodensidade >1/3 do território da ACM contraindica trombólise. ASPECTS ≥ 6 para trombectomia	≤ 25 min da chegada, laudo ≤ 45 min (meta porta-imagem). Se não há TC local → transferir sem esperar [VERIFICAR]
Angio-TC (Centro de AVC)	Oclusão de carótida intracraniana/M1/basilar → trombectomia	No centro receptor; não atrasar trombólise por ela (AHA 2026)
ECG	FA, IAM concomitante, alterações de repolarização na HSA	≤ 10 min; não atrasa reperfusão
Hemograma, plaquetas, TAP/RNI, TTPa	Só aguardar resultado antes de trombolisar se: uso de varfarina, heparina, suspeita de plaquetopenia/coagulopatia/hepatopatia [PCDT-MS 2023, seção 5]	Colher e não esperar nos demais
Eletrólitos, ureia/creatinina, troponina, glicemia sérica	Diferenciais, ajuste de fármacos, IAM tipo 2	—
Beta-hCG (mulher em idade fértil)	Gestação não contraindica trombólise, mas muda a discussão	—
Nível de ACOD / função renal	ACOD nas últimas 48 h contraindica trombólise se função renal anormal ou testes indisponíveis	—

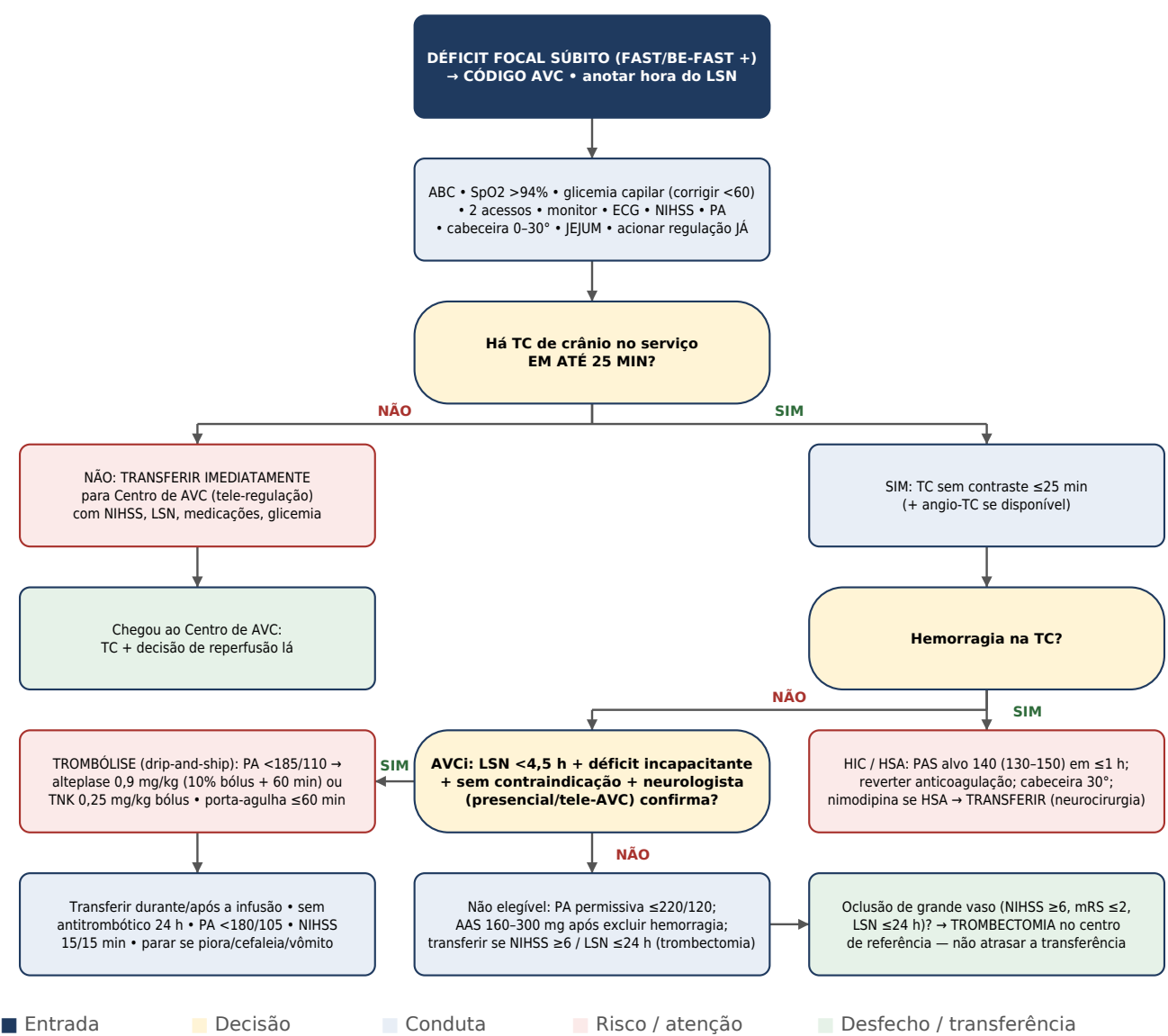
5. Fisiopatologia

AVC isquêmico (75-85%): oclusão arterial por trombose local sobre placa aterosclerótica (grandes artérias cervicais/intracranianas), embolia cardíaca (FA — ~20%), doença de pequenos vasos (lacunas) ou causas raras (dissecção, vasculite, trombofilia); ~30% ficam criptogênicos [PCDT-MS 2023, 1]. Ao redor do núcleo de infarto (fluxo <10 mL/100 g/min, morte em minutos) há a **penumbra** (10-20 mL/100 g/min), tecido silente mas viável cuja sobrevivência depende de reperfusão precoce e de pressão de perfusão — por isso a hipertensão permissiva e a proibição de hipotensão/hipovolemia. A recanalização tardia ou de área já infartada causa **transformação hemorrágica**, o risco central da trombólise (HIC sintomática ~6%).

Hemorragia intracerebral (10-15%): ruptura de arteríolas perfurantes lesadas por hipertensão crônica (núcleos da base, tálamo, ponte, cerebelo) ou de vasos com angiopatia amiloide (lobar, idoso); anticoagulantes ampliam o hematoma. O hematoma cresce nas primeiras 3-6 h ("spot sign"), e o controle pressórico precoce reduz a expansão. **Hemorragia subaracnóidea (5%):** ruptura de aneurisma sacular; risco de ressangramento máximo nas primeiras 24 h e de vasoespasma entre o 3º e o 14º dia.

6. Fluxo de atendimento

Tudo corre em paralelo: a regulação é acionada **antes** da tomografia. O relógio começa no LSN, não na chegada.



6.1 Metas de tempo (AHA 2026; Linha de Cuidado MS)

Intervalo	Meta
Porta-avaliação médica / NIHSS	≤10 min
Porta-TC (quando existe)	≤25 min; laudo ≤45 min
Porta-agulha (trombólise)	≤60 min (ideal ≤45 min)
Porta-saída para transferência (sem TC local)	≤30 min
LSN-trombólise	≤4,5 h
LSN-punção arterial (trombectomia)	≤6 h (padrão); até 24 h com imagem de perfusão/critérios do PCDT

6.2 Critérios do PCDT-MS 2023 para trombólise (seções 4 e 5) — checklist

INCLUSÃO (todos)	CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS
☐ ≥18 anos ☐ Neurologista confirma AVCi (presencial ou tele-AVC) ☐ LSN < 4,5 h até o início da infusão ☐ TC/RM sem hemorragia ☐ Déficit incapacitante (AHA 2026: não trombolisar déficit leve não incapacitante) ☐ Paciente/responsável ciente dos riscos (registrar)	☐ Hipodensidade >1/3 do território da ACM ou resolução completa espontânea ☐ Cirurgia de grande porte ≤14 dias ☐ HIC prévia; MAV ou tumor intracraniano ☐ PAS >185 ou PAD >110 não responsiva a anti-hipertensivo ☐ Suspeita de HSA (mesmo com TC normal) ☐ Hemorragia GI/GU ≤21 dias; sangramento interno ativo ☐ Plaquetas <100.000; RNI >1,7; TTPa >40 s ☐ ACOD ≤48 h com função renal anormal/testes indisponíveis (dabigatрана: reverter com idarucizumabe e trombolisar) ☐ HBPM em dose plena ≤24 h ☐ Endocardite bacteriana; dissecação de aorta

Relativas (pesar risco-benefício): déficit leve; cirurgia intracraniana, TCE ou AVC grave ≤3 meses; punção lombar ≤7 dias; IAM ≤3 meses; punção arterial não compressível ≤7 dias; glicemia <50 com reversão do déficit. **Não são contraindicação:** antiagregante em uso, crise convulsiva no início, aneurisma não roto conhecido, idade >80, NIHSS >22, AVC prévio + diabetes [PCDT-MS 2023, Nota 1].

6.3 Modelo drip-and-ship — condições mínimas para trombolisar neste PS [VERIFICAR/PACTUAR]

- TC de crânio 24 h com laudo (local ou por telerradiologia) e neurologista por tele-AVC 24 h (avaliação obrigatória pelo PCDT).
- Trombolítico em estoque (alteplase 50 mg + 20/10 mg ou tenecteplase 25 mg), bomba de infusão, monitor, anti-hipertensivo IV, hemocomponentes acessíveis.
- Transporte avançado pactuado para saída em ≤30 min após o bólus, com destino a Centro de AVC com neurocirurgia e UTI.
- Sem essas condições: **não trombolisar**; transferir imediatamente — a janela de 4,5 h pertence ao centro de referência.

6.4 AIT (déficit resolvido)

- Não dar alta do PS sem: ECG, glicemia, TC (ou transferência para realizá-la), ABCD² (idade ≥60 =1; PA ≥140/90 =1; clínica: fraqueza unilateral =2, fala sem fraqueza =1; duração ≥60 min =2, 10-59 min =1; diabetes =1).
- ABCD² ≥4, FA, sopro carotídeo, AIT em crescendo ou déficit motor/afasia → **internar/transferir** para investigação em 24-48 h (imagem vascular, eco).
- Iniciar AAS 160-300 mg + clopidogrel 300-600 mg de ataque, depois DAPT por 21 dias (CHANCE/POINT) se AIT de alto risco ou AVC menor (NIHSS ≤3-5) sem indicação de anticoagulação; estatina de alta intensidade.

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Medidas gerais (todo AVC)

Medida	Conduta
Decúbito	Cabeceira 0° (AVCi sem risco de aspiração/HIC) ou 30° (HIC, HSA, hipóxia, vômitos)
Oxigênio	Só se SpO ₂ ≤94%; alvo >94%
Volemia	SF 0,9% ou Ringer 1–1,5 mL/kg/h; sem soluções hipotônicas/glicosadas ; corrigir hipovolemia
Glicemia	Alvo 140–180 mg/dL; insulina se >180; glicose 50% 20–40 mL se <60 (+ tiamina 100 mg IV se etilista/desnutrido)
Temperatura	Dipirona/paracetamol se ≥37,5 °C; buscar foco
Jejum	Nada VO (inclusive comprimidos) até triagem de disfagia; após trombólise, 24 h de jejum absoluto
Sonda vesical	Evitar; só se retenção ou monitorização de diurese em paciente grave
Convulsão	Tratar (diazepam/midazolam → fenitoína ou levetiracetam); sem profilaxia de rotina no AVCi ou HIC
Profilaxia de TEV	Compressão pneumática intermitente desde a admissão; enoxaparina 40 mg SC 1×/dia após 24 h de trombólise; na HIC, só após 24–48 h de estabilidade do hematoma

7.2 Pressão arterial

Cenário	Alvo	Fármacos (titular; evitar quedas >15% em 24 h)
AVCi candidato a trombólise	<185/110 antes do bólus; <180/105 nas 24 h seguintes (aferir a cada 15 min por 2 h, 30 min por 6 h, 60 min por 16 h)	Metoprolol 5 mg IV lento (repetir até 15 mg); esmolol 500 mcg/kg bólus + 50–200 mcg/kg/min; nitroprussiato 0,25–10 mcg/kg/min se refratário (cautela com PIC); hidralazina 10–20 mg IV. Não usar nifedipino SL . Se PA não controla → não trombolisar
AVCi não candidato	Hipertensão permissiva: tratar só se >220/120 (ou IAM, dissecação, IC, eclâmpsia), reduzindo ≤15% em 24 h	Idem, em doses menores; manter anti-hipertensivo oral habitual só após 24–48 h e triagem de disfagia
Hemorragia intracerebral	PAS 140 mmHg (faixa 130–150), atingido em ≤1 h e mantido suave; evitar PAS <130 [AHA-HIC 2022]	Esmolol/metoprolol/nitroprussiato/hidralazina; nicardipino ou clevidipino se disponíveis [VERIFICAR]
Hemorragia subaracnóidea	PAS <160 até tratamento do aneurisma; evitar hipotensão	Idem + nimodipina 60 mg VO/SNG 4/4 h por 21 dias (previne vasoespasmo) [AHA-HSA 2023]
Hipotensão (raro)	PAS >100 / PAM >70	Volume; noradrenalina se refratária

7.3 Trombolítico (somente com neurologista + TC — seção 6.3)

Fármaco	Dose	Observações
Alteplase (único do PCDT-MS/SUS)	0,9 mg/kg (máx. 90 mg) : 10% em bólus IV em 1 min, restante em 60 min em bomba [PCDT-MS 2023, 7.1]	Frascos 50/20/10 mg; peso real (estimado se necessário, registrar); nada VO 24 h; sem antitrombótico 24 h; TC de controle em 24 h antes de AAS
Tenecteplase 25 mg (aprova Anvisa dez/2025; AHA 2026 classe I)	0,25 mg/kg (máx. 25 mg) , bólus IV único em 5–10 s	Não usar a apresentação cardiológica (dose diferente); ainda não consta do PCDT-MS — uso conforme pactuação e disponibilidade [VERIFICAR]
Complicação: angioedema orolingual	Suspender infusão; metilprednisolona 125 mg IV + difenidramina/prometazina + ranitidina; adrenalina 0,3 mg IM se via aérea ameaçada	Maior risco em usuários de IECA
Complicação: HIC sintomática (piora de NIHSS ≥4, cefaleia, vômito, PA súbita)	Parar infusão; TC urgente; crioprecipitado 10 U (+10 U se fibrinogênio <150); ácido tranexâmico 1 g IV; plaquetas se <100.000; neurocirurgia	Transferência de emergência

7.4 Antitrombóticos no AVCi (sem trombólise, ou 24 h após, com TC de controle)

- **AAS 160-300 mg** nas primeiras 24-48 h (VO ou via sonda após triagem de disfagia; retal se necessário), depois 100 mg/dia.
- **DAPT (AAS + clopidogrel 300-600 mg ataque, depois 75 mg) por 21 dias** em AVC menor (NIHSS $\leq 3-5$) ou AIT de alto risco, iniciada em ≤ 24 h (AHA 2026 reconhece DAPT como não inferior à alteplase no AVC menor não incapacitante).
- **Anticoagulação plena** (FA, trombo intracardíaco): **não** na fase hiperaguda; iniciar conforme tamanho do infarto (AIT: 1-3 dias; pequeno: $\sim 3-4$ dias; moderado: ~ 6 dias; grande: $\sim 12-14$ dias) — decisão do centro de referência.
- Estatina de alta intensidade (atorvastatina 40-80 mg) assim que puder deglutir.

7.5 Hemorragia intracerebral e HSA — condutas imediatas [AHA-HIC 2022; AHA-HSA 2023]

Medida	Conduta
Reversão de anticoagulação	Varfarina: complexo protrombínico 25-50 UI/kg (ou conforme RNI) + vitamina K 10 mg IV; se CCP indisponível, plasma fresco 15-20 mL/kg [VERIFICAR disponibilidade no hemocentro]. Dabigatran: idarucizumabe 5 g IV [VERIFICAR]. Rivaroxabana/apixabana/edoxabana: CCP 50 UI/kg (andexanet indisponível no SUS). Heparina: protamina 1 mg/100 UI (máx. 50 mg). Antiagregante: transfusão de plaquetas não indicada (PATCH) salvo cirurgia
PIC / herniação	Cabeceira 30°, cabeça alinhada, evitar hipotonia/hipercapnia; manitol 20% 0,5-1 g/kg IV ou NaCl 3% 150-250 mL em sinais de herniação (anisocoria, postura) enquanto transfere; hiperventilação breve (PaCO_2 30-35) só como ponte
Convulsão	Tratar se ocorrer; sem profilaxia rotineira
Hemostáticos	Ácido tranexâmico e fator VIIa não recomendados de rotina na HIC espontânea
Indicação neurocirúrgica (transferir para avaliar)	Hematoma cerebelar > 3 cm ou com hidrocefalia/compressão de tronco; hidrocefalia aguda (DVE); hematoma lobar com deterioração; HSA aneurismática (clipagem/embolização em $\leq 24-72$ h)
HSA específicos	Nimodipina 60 mg 4/4 h VO/SNG; analgesia (dipirona, opioide); evitar hipovolemia (euvolemia com SF 0,9%); ácido tranexâmico de curta duração (< 72 h) pode ser considerado até o tratamento do aneurisma (AHA-HSA 2023, 2b) — discutir com a referência
Escore para o relatório	ICH score (Glasgow, volume ≥ 30 mL, intraventricular, infratentorial, idade ≥ 80); Hunt-Hess e Fisher na HSA

8. Como conduzir o caso — transferência, regulação e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Todo AVC agudo com LSN ≤ 24 h (janela de reperfusão) — incluindo AVC ao despertar	Imediata ("código AVC" com a regulação)	Centro de AVC tipo II/III (trombólise + trombectomia + neurocirurgia + UTI)
HIC, HSA, cerebelar, com rebaixamento, anticoagulado	Imediata	Centro com neurocirurgia e UTI
AVC com LSN > 24 h, estável	Mesmo dia	Unidade de AVC/enfermaria de referência para investigação e reabilitação precoce
AIT de alto risco (ABCD ² ≥ 4 , FA, sopro, crescendo)	≤ 24 h	Unidade de AVC / investigação vascular
AIT de baixo risco investigado (TC, ECG, glicemia normais), com DAPT iniciada	Alta com retorno em 48-72 h e APS	—

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192; monitor, oximetria, PA a cada 15 min, acesso duplo, cabeceira conforme o caso, aspiração pronta, glicemia de controle; se trombólise em curso, bomba de infusão e NIHSS a cada 15 min.
- Relatório: **hora do LSN**, hora da chegada, NIHSS inicial e atual, glicemia, PA e drogas usadas com horários, TC (laudo/imagem em mídia ou PACS), medicações em uso (anticoagulante — hora da última dose!), mRS prévio, comorbidades, contato do familiar, peso.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação; acionar tele-AVC se pactuado. Centro de AVC de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026; habilitação como Centro de AVC/trombectomia a confirmar no CNES — retaguarda terciária Campinas/HC-UNICAMP).

8.3 Se o paciente permanecer no PS (sem vaga imediata)

- Reavaliar NIHSS e Glasgow a cada 30–60 min; PA e glicemia conforme seção 7; cabeceira; jejum até triagem de disfagia (teste da água: 3 colheres, depois 50 mL, observando tosse/voz molhada).
- Mobilização precoce após 24 h se estável; prevenção de úlcera de pressão; sonda nasointestinal se disfagia após 24 h.
- Reiterar a regulação a cada 2 h e registrar; a demora de vaga não suspende a janela terapêutica — documentar horários.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de suspeitas com hora do LSN registrada	100%
% com glicemia capilar e NIHSS documentados na admissão	100%
Tempo porta-acionamento da regulação (mediana)	≤15 min
Tempo porta-saída do PS (transferência)	≤30 min (sem TC) / ≤60 min (com trombólise)
Tempo porta-TC e porta-agulha (se drip-and-ship)	≤25 min / ≤60 min
% de AVCi elegíveis que receberam trombólise (no PS ou no centro, dentro da janela)	Registrar e aumentar
% de AIT com ABCD ² e antitrombótico iniciado antes da alta	≥90%
% de pacientes com triagem de disfagia antes de qualquer VO	100%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Trombolítico	PCDT-MS 2023: apenas alteplase (TNK sem bula à época). Anvisa aprovou TNK 25 mg para AVCi em dez/2025; AHA 2026: TNK 0,25 mg/kg classe I. Adotada alteplase como padrão SUS e TNK como alternativa quando disponível/pactuada
Neurologista obrigatório	PCDT exige avaliação de neurologista para trombólise — no PS isso só é viável por tele-AVC; sem ele, não trombolisar
Déficit leve	PCDT: contraindicação relativa; AHA 2026: não trombolisar déficit leve <i>não incapacitante</i> . Adotada a redação da AHA
Janela estendida	PCDT: trombólise só <4,5 h do LSN; AHA 2026 (2a): trombólise em AVC ao despertar/início desconhecido com mismatch de imagem — só em centro com RM/perfusão; fora do escopo do PS
Trombectomia	PCDT: ≤8 h (ACI/M1, NIHSS ≥6, mRS 0-2, ASPECTS ≥6) e 8-24 h com critérios de perfusão; AHA 2026 amplia para large core e basilar — decisão do centro receptor. O PS só precisa reconhecer o candidato e não atrasar
PA na HIC	AHA-HIC 2022: 140 (130-150) precoce; INTERACT3 (2023) reforça pacote de cuidados; evitar <130. Diretriz SBDCV 2009 é anterior — adotada AHA
Agentes de reversão	CCP, idarucizumabe e nicardipino: disponibilidade no PS/hemocentro [VERIFICAR]; sem CCP, plasma fresco
TC local e tele-AVC	Definem se o PS opera drip-and-ship ou só transferência [VERIFICAR/PACTUAR]
Hospital de referência	Habilitação como Centro de AVC (Portaria de Consolidação nº 3/2017) a confirmar no CNES [PACTUAR]

10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo*. Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 29, de 12 de dezembro de 2023. gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.996, de 24/11/2023 (trombectomia mecânica no SUS); Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017, arts. 128-137 (Linha de Cuidado do AVC na RUE); Portaria GM/MS nº 664 e 665/2012 (histórico).
- AHA/ASA. 2026 *Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke*. Stroke 2026 (atualiza Powers WJ, et al. Stroke 2019;50:e344-e418).
- Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al. 2022 *Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage*. Stroke 2022;53:e282-e361.
- Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 *Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage*. Stroke 2023;54:e314-e370.
- Oliveira-Filho J, Martins SCO, Pontes-Neto OM, et al. Guidelines for acute ischemic stroke treatment: part I. Arq Neuropsiquiatr 2012;70(8):621-629; Martins SCO, et al. Part II. Arq Neuropsiquiatr 2012;70(11):885-893.
- Pontes-Neto OM, Cougo P, Martins SCO, et al. Brazilian guidelines for endovascular treatment of patients with acute ischemic stroke. Arq Neuropsiquiatr 2017;75(1):50-56.
- Ma H, et al. (EXTEND) N Engl J Med 2019; Thomalla G, et al. (WAKE-UP) N Engl J Med 2018; Menon BK, et al. (AcT) Lancet 2022; Johnston SC, et al. (POINT) N Engl J Med 2018; Wang Y, et al. (CHANCE) N Engl J Med 2013; Baharoglu MI, et al. (PATCH) Lancet 2016; Ma L, et al. (INTERACT3) Lancet 2023.
- Anvisa. Registro de Metalyse® 25 mg (tenecteplase) — indicação AVC isquêmico agudo, dez/2025. SBAVC, nota de abr/2026.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de AVC (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração